

ACESSO DE HD — SALVAR A FÍSTULA

TIPOS DE ACESSO E PROBLEMAS

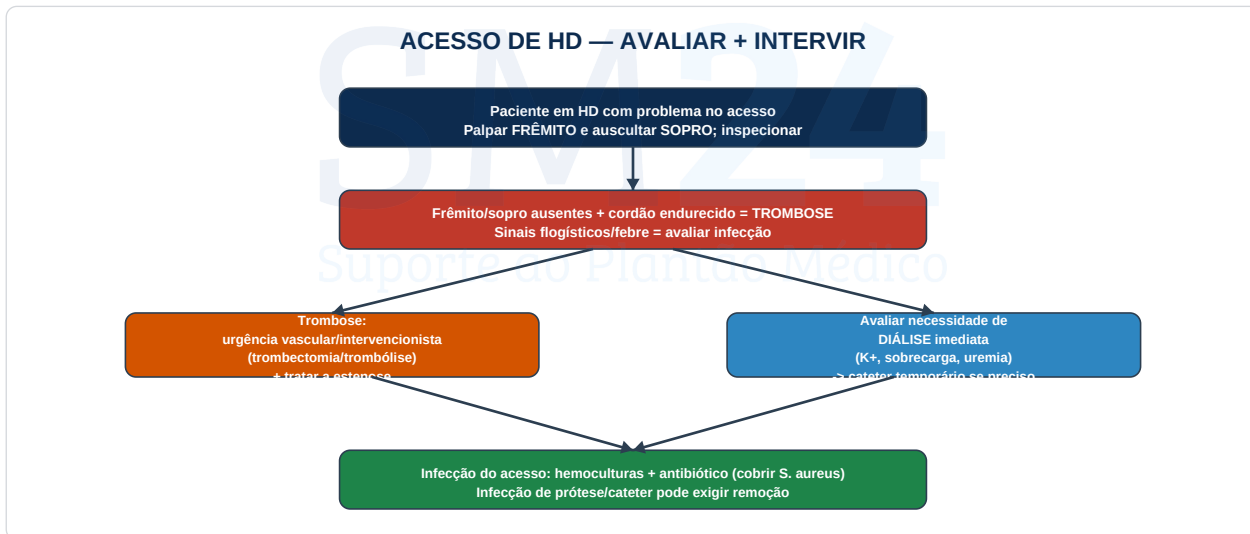
Acesso	Características	Complicações
FAV nativa	Anastomose artéria-veia; melhor patência e menor infecção	Estenose, trombose, baixo desenvolvimento, aneurisma
Prótese (enxerto PTFE)	Quando não há veias nativas adequadas	Maior risco de trombose e infecção que a FAV
Cateter venoso central	Acesso temporário/permanente	Infecção (a mais grave), trombose,estenose venosa central
Disfunção (sem trombose)	Estenose: queda do fluxo, dificuldade de punção, pressões venosas altas	Tratar (angioplastia) para prevenir trombose
Trombose	Ausência de frêmito/sopro, cordão endurecido	Urgência para salvar o acesso

TROMBOSE DO ACESSO — JANELA PARA SALVAR

FRÊMITO E SOPRO AUSENTES = TROMBOSE

- Trombose: desaparecimento do frêmito (thrill) e do sopro, com cordão endurecido e doloroso no trajeto do acesso
- É uma urgência: quanto antes a desobstrução (trombectomia ou trombólise + tratar aestenose subjacente), maior a chance de salvar o acesso
- A maioria das trombooses ocorre sobre uma ESTENOSE — corrigir aestenose (angioplastia) é essencial para não retrombosar
- Encaminhar à cirurgia vascular / radiologia intervencionista com urgência
- Avaliar a necessidade de diálise imediata (hipercalcemia, sobrecarga, uremia) — pode exigir cateter temporário
- Não puncionar repetidamente um acesso trombosado/infectado

ABORDAGEM DO ACESSO DISFUNCIONAL/TROMBOSADO



OUTRAS COMPLICAÇÕES DO ACESSO

Complicação	Quadro	Conduta
Sangramento	Pós-punção ou ruptura de pseudoaneurisma	Compressão digital (não ocluir totalmente); cirurgia se ruptura
Infecção	Calor, rubor, secreção, febre; bacteremia (cateter)	Hemoculturas + antibiótico anti-S. aureus; remover cateter/prótese se necessário
Isquemia da mão (roubo)	Dor, palidez, frialdade distais ao acesso	Avaliação vascular; pode exigir correção cirúrgica
Pseudoaneurisma/aneurisma	Dilatação pulsátil; risco de ruptura se pele fina	Avaliação cirúrgica; risco de sangramento
Estenose venosa central	Edema do membro/face (cateter prévio)	Angioplastia; evitar punções que agravem

URGÊNCIAS ASSOCIADAS E CUIDADOS

Sangramento do Acesso

- Compressão digital firme, mas SEM ocluir totalmente o acesso (preservar o fluxo)
- Elevar o membro; manter a compressão por tempo suficiente
- Ruptura de aneurisma/pseudoaneurisma com sangramento ativo = emergência cirúrgica
- Torniquete proximal apenas como medida temporária extrema se hemorragia incontrolável
- Corrigir distúrbios de coagulação se presentes
- Encaminhar à cirurgia vascular

Diálise de Urgência (se preciso)

- Indicações (AEIOU): acidose, hipercalemia, intoxicação, sobrecarga, uremia
- Acesso trombosado/infectado pode exigir cateter temporário
- Hipercalemia com ECG alterado: gluconato de cálcio + medidas + diálise
- Evitar puncionar acesso infectado
- Comunicar a nefrologia e a vascular
- Planejar a recuperação do acesso definitivo

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Examinar o acesso: frêmito, sopro, cordão, sinais flogísticos e isquemia da mão
- ☐ Frêmito/sopro ausentes = trombose: urgência para tentar salvar o acesso
- ☐ Encaminhar à cirurgia vascular / radiologia intervencionista precocemente
- ☐ Tratar a estenose subjacente (angioplastia) para evitar retrombose
- ☐ Avaliar necessidade de diálise imediata (hipercalemia, sobrecarga, uremia)
- ☐ Infecção: hemoculturas + antibiótico anti-S. aureus; sangramento: compressão digital sem ocluir totalmente

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente em hemodiálise nota que o frêmito da fístula desapareceu, com cordão endurecido e doloroso. Qual a conduta?

- A) Observar e retornar para a próxima sessão de diálise
- B) Urgência: encaminhar à cirurgia vascular/intervencionista para desobstrução, tratando a estenose subjacente
- C) Apenas analgesia
- D) Puncionar o acesso repetidamente para testar
- E) Antibiótico oral e alta

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

A maioria das trombozes de fístula arteriovenosa ocorre sobre qual lesão de base, que precisa ser tratada para evitar retrombose?

- A) Aneurisma
- B) Estenose
- C) Infecção
- D) Isquemia da mão
- E) Edema do membro

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Diante de sangramento no local de punção da fístula, qual a conduta correta?

- A) Ocluir totalmente o acesso com torniquete apertado de rotina
- B) Compressão digital firme SEM ocluir totalmente o acesso (preservando o fluxo)
- C) Não comprimir e elevar apenas
- D) Suturar imediatamente no PS sem avaliação
- E) Aplicar calor local

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Paciente em HD com acesso trombosado e hipercalemia com alteração no ECG. Qual a prioridade?

- A) Aguardar a recuperação do acesso
- B) Tratar a hipercalemia (gluconato de cálcio + medidas) e providenciar diálise de urgência, com cateter temporário se necessário
- C) Apenas dieta pobre em potássio
- D) Antibiótico empírico
- E) Repetir o ECG em 6 horas

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual a complicação mais grave associada ao cateter venoso central para hemodiálise?

- A) Edema do membro
- B) Infecção/bacteremia (com risco de sepse)
- C) Hematoma leve
- D) Dor local transitória
- E) Frêmito aumentado

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O desaparecimento do frêmito com cordão endurecido indica trombose da fístula — uma urgência. Deve-se encaminhar prontamente à cirurgia vascular/radiologia intervencionista para desobstrução (trombectomia/trombólise) e tratamento da estenose subjacente, a fim de salvar o acesso.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A maioria das trombozes de FAV/prótese ocorre sobre uma estenose preexistente (geralmente na anastomose ou no trajeto venoso). Corrigir a estenose (angioplastia) é essencial para evitar a retrombose precoce.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

No sangramento do acesso, faz-se compressão digital firme SEM ocluir totalmente o fluxo (para não trombosar a fístula). Ruptura de aneurisma com sangramento ativo é emergência cirúrgica; o torniquete proximal é medida extrema temporária.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A hipercalemia com alteração no ECG é a prioridade imediata (risco de arritmia fatal): gluconato de cálcio + medidas de redistribuição, seguida de diálise de urgência. Com o acesso trombosado, pode ser necessário um cateter temporário.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A complicação mais grave do cateter venoso central para HD é a infecção/bacteremia, que pode evoluir para sepse. Por isso a FAV nativa é preferida (menor risco infeccioso) e o cateter infectado frequentemente precisa ser removido.

SM24
Suporte ao Plantão Médico